

Fecha Última Actualización: 11-03-2022 7:49:54

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Manuel Hipolito Pedraza Oyanedel **Rut** : 6.749.333-8 **N° Archivo** : 1129752
Edad : 70a 5m 2d **Fecha Nacto**: 09/10/1951 **Sexo** : Masculino
Dirección : El Sauce 0253 Casas Viejas - Puente Alto **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 7447 1345

N° Epicrisis
297767

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 05/02/2022 01:29 **Días Estadía**: 34
Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía **Fecha Egreso** : 11/03/2022 07:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EGRESO UTIN

FI CASR 05.02.22
FI UCI 05.02.22
FI UTIN 01.03.22

ANAMNESIS REMOTA:

- A. médicos: TAB, hipertensión esencial
- A. quirúrgicos: Niega
- Alergias o RAMs: Niega
- Fármacos: Ácido Valproico 250 mg 2-0-2, Quetiapina 100 mg: 1/- 0- 3 + ¿ SOS, Bupropion 150 mg 3-0-0, Clonazepam 2 mg: ¿- 0 ¿ 1 noche
- Hábitos: Tabaquismo activo, OH activo

ANAMNESIS PRÓXIMA:

Paciente con antecedentes descritos, ingresó el 05.02.22 a reanimador de SU CASR, en contexto, de convulsión TCG que no respondió a Lorazepam, por lo que se interpretó como status epiléptico. Ante lo expuesto, se conectó a VMI y se cargó con Fenitoína. Estudio de imágenes evidenció tumor frontal que desplazaba línea media, con edema perilesional importante. Se informo a neurocirugía y se trasladó a UPC para continuar manejo.

En lo ventilatorio, se mantuvo con VMI protectora. Se extubó el día 08/02, con falla lo más probable 2río a infección por lo que debió reintubarse. Se logra extubar el día 21/02, persistiendo con necesidad de O2 suplementario, actualmente a la baja, requiriendo 1- 2 L de O2 por naricera, saturando en rango, aún con secreciones bronquiales. Ante lo expuesto, solicitó Rx tórax y mantengo broncodilatación y KTR. En plan de destete de O2.

En lo infeccioso, inicialmente destacó PCR Covid 19 (+) sin repercusión clínica. Posteriormente, evolucionó febril, por lo que se pancultivo el día 10/02 aislándose una Raoutella + H Influenza en CAET y en HMC un SAMS + Raoutella, se trató con Tazonam + Vancomicina con buena respuesta. El día 18/02 nuevamente es cultivado, ante alza de parámetros inflamatorios, aislándose Klebsiella Blee+ y un Enterobacter en CAET quedando con Imipenem más amikacina en NBZ. Actualmente, en día 6/7 de Imipenem, suspendiéndose ayer Amikacina.

En lo neuroquirúrgico, RNM cerebro evidenció una lesión tumoral sospechosa de glioblastoma de alto grado. EEG 08/02, con frecuente lentitud intermitente temporal izquierda, DLGG, reactiva. Ingreso a pabellón el 14.02 realizándose una exeresis

Fecha Epicrisis : 11/03/2022 07:49

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 11-03-2022 7:49:54

Página 2 de 3

tumoral, pendiente aún biopsia. TAC cerebro control con Neumoencéfalo, sin complicaciones. Postpabellón se mantuvo con corticoides y antibioticoterapia, dado aislamiento de SAMS se descaló a cefazolina completando tratamiento. Actualmente, sin corticoterapia ni bacteremia, no ha vuelto a convulsionar y mantiene terapia con Fenitoína, Levetiracetam y Ácido Valproico. Se describe en ficha aparente RAM a PHT, pero no se encuentran más detalles.

En lo renal, destacó en el último período diuresis aumentada, con Na a la baja. Actualmente, con hiponatremia/Hipoclorémica y clínicamente deshidratado por lo que se administra volumen, pendiente control inmediato ELP para definir conducta.

En lo nutricional, mantener alimentación por sonda nasogástrica y enteral sólo por fonoaudióloga. Seguimiento por fonoaudiología.

En lo psiquiátrico, se reinicia Clonazepam. Mantengo terapia crónica. Seguimiento por especialidad.

Se traslado el 01.03 a UTIN donde se mantuvo sin conflicto hemodinámico ni ventilatorio, afebril y completando tratamiento antibiótico. Refirió dolor testicular sin banderas rojas, solicitando IC a especialidad. Actualmente, en 16avo día postoperatorio, sin conflicto neurológico, manteniendo FAE, completando tratamiento antibiótico y en seguimiento por psiquiatría. Ante estabilidad clínica se decide traslado a sala para continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS EGRESO:

1. Tumor cerebral operado 14/02/22

Obs. Glioblastoma de alto grado, Biopsia pendiente

2. Status convulsivo resuelto

3. Neumonía por Klebsiella BLEE (en tto.)

4. Bacteremia por SAMS tratada

5. COVID19 PCR (+) 14/02 hallazgo pre operatorio

6. Hiponatremia leve

7. Delirium mixto en regresión

8. Obs RAM a Fenitoína

9. Antecedentes: TAB, HTA, Tabaquismo, OH crónico, consumo marihuana, sospecha de T. de Personalidad, Paresia VI par izquierdo 2013 RNM sin lesiones.

INGRESO A SALA.

Paciente ingresa en buenas condiciones generales con sonda nasogastrica.

Se retiró el día Viernes 4/3 sin complicaciones. Actualmente comiendo regimen liviano sin granos y liquidos espesos.

Presentó hiponatremia de 127. Se corrigió con NaCl 3%.

Actualmente 137.

Sin otras complicaciones. Se decide alta con hospitalización domiciliaria.

Diagnóstico de Egreso

Tumor de comportamiento incierto del encéfalo, parte no especificada -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Vigil, ubicado TE, sin afasia ni disartria.

Motor al menos M4 en 4 extremidades.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Regimen segun evaluacion por fonoaudiologo.

Hospitalización domiciliaria para fonoaudiología y kinesiología.

Ácido Valproico 500mg c/8 hrs

Levetiracetam 1gr cada 12 hrs

Quetiapina 25mg-50mg- 50mg

Haloperidol 5mg SOS si agitación

Br. de Ipatropio/Fenoterol 4 puff c/6 hrs

Budesonida 2 puff c/12 hrs

Paracetamol 1gr SOS c/8 hrs si T>37.5°C o dolor

Ketoprofeno 100mg SOS c/8 hrs si dolor

Omeprazol 20 mg al día

Control con Neurocirugia. Dr. Soto la proxima semana. Solicitar hora con este documento en CDT.

Se explican sintomas de alarma y control SOS SU.

Fecha Epicrisis : 11/03/2022 07:49

Página 2 de 3

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Jose Pablo Diaz Lorenzo

Becado/Residente

Estefanía Meza Fabia

Médico Tratante (Staff)